

<みたき透析室で使用する薬剤（静注・内服）について>

静注薬

●抗凝固薬

- ・ヘパリン

半減期：1.0～1.5 時間

- ・ダルテパリン（低分子ヘパリン）

半減期：2.0～3.0 時間

適応：軽度出血性病変、止血不良

- ・ナファモスタット

半減期：5～8 分

適応：出血性病変

注意点：積層型ダイアライザーとの併用は禁忌

ワンショットを行うとショックが起こることがあるため禁忌

●二次性副甲状腺機能亢進症 治療製剤

◇活性型ビタミン D3 製剤

- ・カルシトリオール

腎不全ではビタミン D3 の活性化ができず低 Ca 血症になるため薬で補う。

小腸からの Ca 吸収を促進し血中 Ca を増やす。

注意点：開始後高 Ca が起こりやすい。

◇カルシウム受容体作動薬

- ・ パーサピブ
- ・ ウパシタ

PTH を低下させる薬。

血中の Ca 濃度が低下すると Ca 受容体が感知して、PTH の分泌を促進させる。

→Ca 受容体作動薬が Ca 受容体を刺激し PTH の分泌を抑制。

簡単にいうと、Ca の濃度が低下していても Ca がいっぱいある、と勘違いさせて PTH を抑制する薬。

注意点：開始後低 Ca が起こりやすい。

●腎性貧血改善薬

◇エリスロポエチン製剤

- ・ エポエチンアルファ
- ・ ダルベポエチンアルファ
- ・ ミルセラ

半減期：エポエチンアルファ…7 時間（週 1 ～ 3 回投与）

ダルベポエチンアルファ…25 時間（週 1 回投与）

ミルセラ…200 時間（月 1 ～ 2 回投与）

◇鉄製剤

- ・フェジン

注意点：5 %ブドウ糖液で希釈し投与。

生食で希釈すると沈殿が生じるため禁忌。

●その他

- ・生理食塩液（0.9%）
- ・ブドウ糖液（5%）

血漿浸透圧とほぼ等しい等張液

- ・強力ミノファージェンシー

抗アレルギー効果（皮膚掻痒症）

- ・グリセオール

主に透析導入期に不均衡症候群を防ぐために使用。

浸透圧物質。

- ・ノルアドレナリン

昇圧剤（作用は後述）

- ・ニカルジピン（ペルジピン）

降圧剤（Ca 拮抗薬）

血管にある Ca チャンネルに結合し細胞内への Ca イオンの流入を減らす。

→末梢血管が弛緩（拡張）し降圧効果。

・ コルスバ

皮膚掻痒症に使用

・ アミノレバン

慢性肝障害 改善薬

・ セファゾリン

抗生剤

内服薬

●昇圧薬

$\alpha 1$ 刺激作用→血管収縮力増加

$\beta 1$ 刺激作用→心収縮増加

- ・リズミック（アメジニウム）

作用： $\alpha 1$ と $\beta 1$

ノルアドレナリンを増やせて命令をだす。

血中濃度が最高になるのは内服2～3時間後。

- ・ドプス

作用： $\alpha 1$ と $\beta 1$

ノルアドレナリンの進化前。

血中濃度が最高になるのは内服5時間後。

- ・メトリジン（ミドドリン）

作用： $\alpha 1$ のみ

血中濃度が最高になるのは1～2時間後。

●その他

- ・エベレンゾ

貧血改善薬。

血中に酸素があっても低酸素状態と勘違いさせる薬。低酸素状態と勘違いし赤血球を産生する。

注意点：内服開始後、副作用で胃部不快感が起こりやすい。

- ・芍薬甘草湯（68）

透析中の筋けいれん対策に使用。内服後5分ほどで効果発現。効果は4～6時間持続。

- ・カリメート

カリウム抑制薬。

災害時に患者に飲んでもらうよう指導。カリウムと結合し糞便中にカリウムを排泄。